



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PROGRAM KERJA
INSTALASI REKAM MEDIS
RS PRIMA HUSADA MALANG
PERIODE TAHUN 2026**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com



PROGRAM KERJA INSTALASI REKAM MEDIS
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA MALANG
PERIODE TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. UMUM DAN LATAR BELAKANG

Rumah sakit adalah semua sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, gawat darurat, tindakan medik yang dilaksanakan selama 24 jam melalui upaya kesehatan perorangan. Dalam penyelenggaraan pelayanan rumah sakit, maka rumah sakit harus melakukan upaya peningkatan mutu pelayanan umum dan pelayanan medik baik melalui akreditasi, sertifikasi, ataupun proses peningkatan mutu lainnya.

Dalam perkembangannya rumah sakit telah berubah menjadi suatu institusi yang sangat kompleks sehingga memerlukan suatu manajemen yang baik. Dengan mengikuti standar akreditasi rumah sakit di Indonesia maka diharapkan rumah sakit akan dapat memberikan sebuah pelayanan yang baik, pelayanan yang baik ini tidak akan terwujud apabila rumah sakit tidak memperhatikan fasilitas keamanan untuk pasien (*patient safety*), pengunjung, dan petugas (Keselamatan dan Kesehatan Kerja).

Upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan dapat diartikan keseluruhan upaya dan kegiatan secara komprehensif dan integrative yang menyangkut struktur, proses, outcome secara objektif, sistematis dan berlanjut memantau dan menilai mutu dan kewajiban pelayanan terhadap pasien, menggunakan peluang untuk meningkatkan pelayanan pasien, dan memecahkan masalah-masalah yang terungkap sehingga pelayanan yang diberikan di rumah sakit berdaya guna dan berhasil guna.

Mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit perlu didukung oleh sumber daya yang dimiliki, salah satunya Bidang Penunjang Instalasi Rekam Medis, Mutu pelayanan kesehatan di rumah sakit perlu di dukung oleh sumber daya manusia, sarana, prasarana, peralatan medis, dan anggaran rumah sakit yang memadai. Berdasarkan Visi Rumah Sakit yaitu “Menjadi Rumah Sakit Berkualitas Prima Pilihan seluruh Lapisan Masyarakat”, oleh karena itu diperlukan suatu Program Kerja Instalasi Rekam Medis guna peningkatan mutu pelayanan Rumah Sakit pada tahun 2025.

A. Gambaran Umum Rumah Sakit

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1) Nama RS | : | RS Prima Husada Malang |
| 2) Alamat | : | Banjararum Selatan No 3 – 7 Singosari
Malang |
| 3) Ijin Operasional | : | 81201150815810001 |
| 4) Akreditasi | : | Paripurna |
| 5) Jumlah TT | : | 129 TT |
| 6) Kelas RS | : | RS Tipe C |
| 7) Visi | : | Menjadi Rumah Sakit berkualitas prima
pilihan seluruh lapisan masyarakat |
| 8) Misi | : | 1. Memberikan pelayanan Kesehatan
dengan aman, tepat, cepat dan akurat
2. Mengutamakan kepuasan dan
keselamatan pasien
3. Meningkatkan mutu pelayanan yang
berkelanjutan |
| 9) Moto | : | Sahabat menuju sehat |



1.2. DASAR HUKUM

Dalam penyelenggaraan Rumah Sakit harus berdasarkan peraturan dan undang – undang yang berlaku, diantaranya:

1. Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Bidang Perumahan sakitan
2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit
3. Undang – Undang No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien
5. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Penyelenggara Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit
7. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud dan Tujuan Umum

Terselenggaranya pelayanan rumah sakit secara optimal sesuai visi dan misi Rumah Sakit.

1.3.2. Maksud dan Tujuan Khusus

1. Terselenggaranya pelayanan Rekam Medis Rumah Sakit yang bermutu
2. Tersedianya sumber daya manusia Rekam Medis yang professional dan berkualitas
3. Tersedianya sarana, prasarana dan peralatan medis yang memadai di Rekam Medis.
4. Terciptanya kerjasama antar instalasi dan bidang lain yang baik.
5. Terciptanya lingkungan kerja yang aman dan sehat untuk pegawai, pasien dan pengunjung rumah sakit.
6. Terciptanya budaya keselamatan pasien rumah sakit.



BAB II GAMBARAN UMUM

2.1 VISI

Menjadi Rumah Sakit berkualitas prima pilihan seluruh lapisan masyarakat

2.2 MISI

1. Memberikan pelayanan Kesehatan dengan aman, tepat, cepat dan akurat
2. Mengutamakan kepuasan dan keselamatan pasien
3. Meningkatkan mutu pelayanan yang berkelanjutan

2.3 MOTO

Sahabat menuju sehat

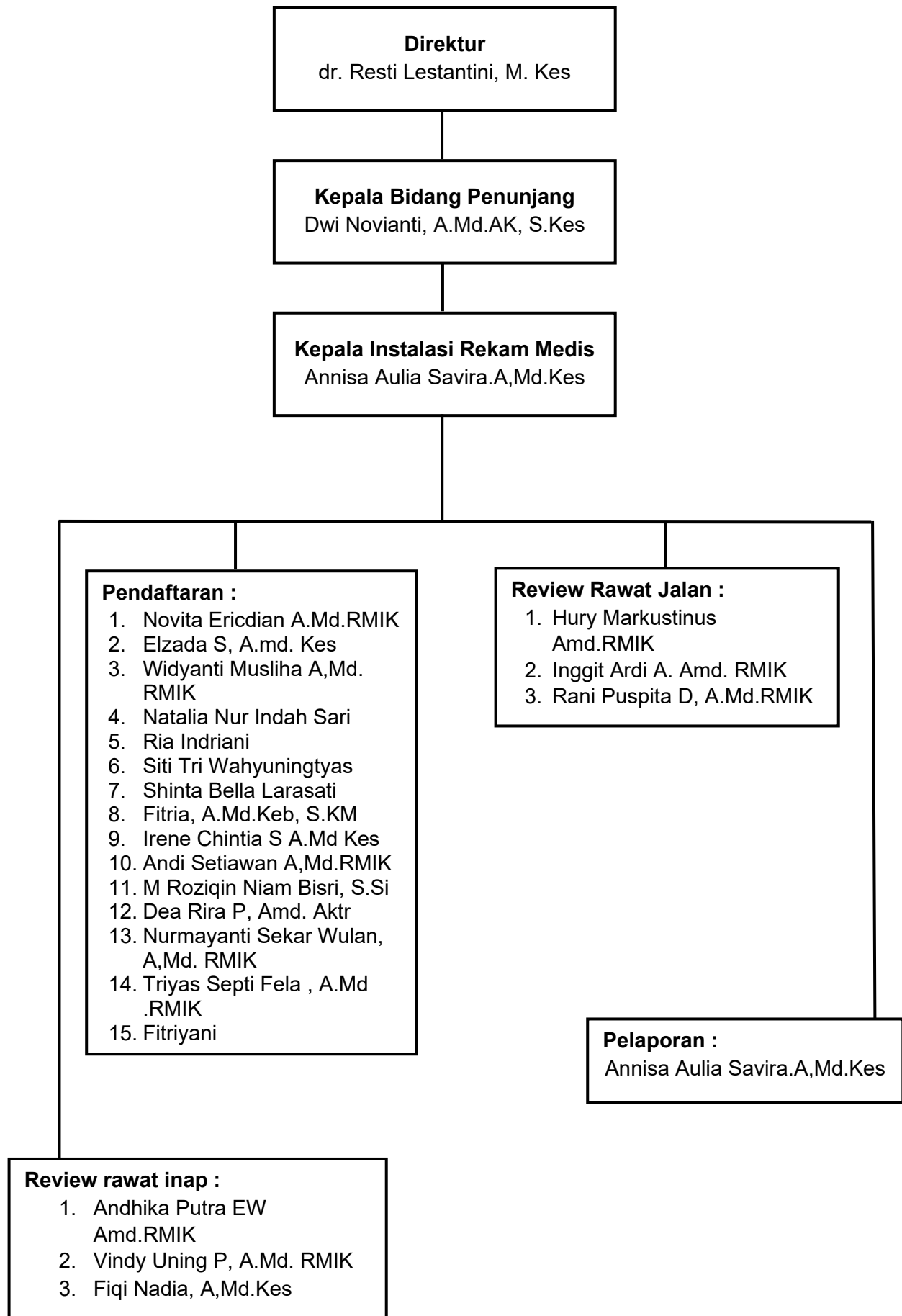
2.4 7 NILAI BUDI UTAMA

1. Jujur
2. Tanggung jawab
3. Visioner
4. Disiplin
5. Kerjasama
6. Adil
7. Peduli



2.5 SOTK

STRUKTUR ORGANISASI UNIT REKAM MEDIS
RS PRIMA HUSADA MALANG





2.5.1 Tanggung Jawab Instalasi Rekam Medis

Dalam pengelolaan organisasinya , secara struktural bagian rekam medis berada di bawah Kepala Bidang Penunjang Medis. Bagian Rekam Medis berfungsi sebagai salah satu “support division” yang memberikan kontribusi maksimal bagi semua “bussiness division”.

Secara fungsional ,bagian rekam medis melaporkan tanggung jawab pelayanan kepada,yakni:

- a. Kepala bidang penunjang
- b. Ka instalasi

2.5.2 Keanggotaan Instalasi Rekam Medis

Bagian Rekam Medis dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi Rekam Medis yang bertanggung jawab secara struktural ke Ka Bid Penunjang Medis dan bertanggung jawab secara fungsional kepala para Ka Unit.

Bagian Rekam Medis RS.Prima Husada secara garis besar terdiri dari :

- a. Pendaftaran
- a. Review rawat jalan atau indeks Dokumen Rekam Medis
- b. Koding dan indeks Dokumen Rekam Medis Rawat Jalan,Rawat Darurat dan Rawat Inap
- c. Asembling (review rawat inap) / perakitan dokumen rekam medis rawat jalan , rawat darurat dan rawat inap
- d. Pelaporan pelayanan internal dan eksternal

2.6 Penyusunan Pola Ketenagaan Sebagai Dasar Penempatan Staf

Dalam upaya mempersiapkan tenaga rekam medis yang handal ,perlu kiranya melakukan kegiatan menyediakan,mempertahankan sumber daya manusia yang tepat bagi organisasi.

Atas dasar tersebut perlu adanya perencanaan SDM,yaitu proses mengantisipasi dan menyiapkan perputaran orang ke dalam,di dalam dan ke luar organisasi.tujuannya adalah mendayagunakan sumber-sumber tersebut seefektif mungkin sehingga pada waktu yang tepat dapat disediakan sejumlah orang yang sesuai dengan persyaratan jabatan.

Perencanaan bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan kemampuan organisasi dalam mencapai sasarnya melalui strategi pengembangan kontribusi.

Tabel 1. Rencana Ketenagaan Instalasi Rekam Medis tahun 2026

Jabatan	Jumlah SDM			Keterangan
	Standar	Saat ini	Kebutuhan	
Instalasi Rekam Medis				
Kepala Instalasi	1	1	0	Sesuai
Pendaftaran	13	13	0	Sesuai
CSO	3	2	1	Belum sesuai
Review irja	3	3	0	Sesuai



Jabatan	Jumlah SDM			Keterangan
	Standar	Saat ini	Kebutuhan	
Review irna	3	3	0	Sesuai
TOTAL	23	22	1	

BAB III
KEGIATAN DAN RINCIAN KEGIATAN

3.1 Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan

3.1.1 Kegiatan Pokok Dan Rincian Kegiatan Instalasi RM RSPHM Tahun 2026

No	Kegiatan Pokok	Rincian Kegiatan
1.	SDM	
1)	Membuat ABK	Membuat analisa beban kerja
2)	Orientasi khusus	Pembuatan Regulasi untuk Instalasi RM : 1. Juknis Orientasi Khusus RM lengkap dg SPO, Alur, PPT nya 2. Pedoman Pelayanan E-RM Teori : (1) Regulasi - (Teori) Lama 1 minggu a. Pedoman b. SPO (bh) c. Alur d. Panduan (2) Tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam pekerjaannya (3) Praktek (lama: 2,5 bulan) a. Penerimaan Pasien dan Pencatatan. b. kodefikasi penyakit sesuai dengan icd 9 dan 10 cm c. analisa, assembling, perbaikan dan sentral (filing) d. Pelaporan (internal dan eksternal) e. retensi (alur)
3)	Diklat	Coding Pelatihan E-RM Komunikasi efektif KIE pasien Pelatihan etika dan pelayanan prima Pelatihan Penggunaan SIMRS untuk Pendaftaran Pasien Pelatihan Komunikasi dan Handling Complaint Pasien di Front Office SKP



		KE-PKRS
		HPK
		PPI DASAR
		MRMIK
		MFK (BHD, APAR,B3, CODE RED, CODE BLUE)
		PMKP (MUTU)
4)	Evaluasi Kinerja	1. Penilaian Kinerja orientasi a. Rekapitan dari laporan Harian selama 11 minggu b. Loogbook orientasi 2. Penilaian Kinerja Staf tiap semesteran 3. Membuat usulan penempatan Kembali staf jika hasil ABK terjadi kekurangan kepada SDM 4. Menerima penempatan staf dari SDM
5)	Pengembangan Pelayanan	Rekam Medis :
		E-RM Seluruh Formulir Rawat Inap Formulir yang belum ERM , antara lain : 1. Identifikasi bayi baru lahir 2. Status Bayi 3. Partograf 4. Lembar Observasi dan Implementasi Harian ICU 5. Lembar Observasi dan Implementasi Harian HCU 6. Lembar Observasi dan Implementasi Harian NICU 7. Observasi Balance Cairan 8. Lembar Resusitasi Pasien 9. Lembar Observasi Ponek 10. Form untuk pasien loadingan 11. Formulir Rujuk Antar RS 12. Surat Kematian
		Scan berkas hard copy di simpan di dalam simrs
		Fitur tambahan (Fitur pelaporan di simrs untuk kebutuhan pelaporan internal dan eksternal RL bulanan dan tahunan)
		Pendaftaran :
		Mesin APM (Anjungan Pendaftaran Mandiri)
6)	Pelayanan	1. Melakukan identifikasi pasien dengan jelas dan lengkap pada pasien baru dan lama baik rawat jalan, rawat inap, maupun gawat darurat 2. Memberikan KIE (General Consent, HPK) Admin pendaftaran : penerbitan SEP di V-Claim , transfer ke SIMRS 3. Memberikan surat control dan ringkasan pulang pasien post rawat inap



7)	Penerimaan Pasien dan Pencatatan	1. Audit kelengkapan keakuratan E-RM Rawat Inap, IGD, IRJA. 2. Merakit berkas rekam medis baik yang belum digunakan maupun setelah digunakan (manual) jika masih ada kendala E-RM (IRNA) 4. Scan DRM yang masih aktif dan di masukan ke dalam vitur simrs agar kemanan bisa terjamin.
8)	Assembling	1. Mengumpulkan, menghitung, dan menganalisa data-data dari kegiatan maupun data-data medis dan non-medis yang ada direkam medis sehingga menjadi laporan atau informasi yang dibutuhkan baik oleh pihak intern maupun ekstern 2. Menampilkan dalam bentuk tabel, grafik, analisis, RTL (rencana tindak lanjut)
9)	Analisa	1. Mengaktifkan Tim Review RM 2. Melakukan review kelengkapan material berkas rekam medis elektronik 3. Membuat pelaporan kegiatan Review RM-e open dan close
10)	Review dan Telaah RM	1. Telaah Pengisian RM-e maupun manual (diisi/tidak ada (-))
11)	Coding	1. Pemberian kode dengan meggunakan huruf atau angka atau kombinasi huruf dan angka yang mewakili komponen data. Buku panduan yang digunkan adalah buku di keluarkan oleh WHO dan untuk kode penyakit menggunakan buku ICD-10 dan untuk kode tindakan menggunakan buku ICD-9 CM
12)	Penyimpanan	1. Penyimpanan rekam medis elektronik berbasis digital
13)	Retensi dan Pemusnahan	1. Pemilahan, penyusutan dan pemusnahan DRM Inaktif. 2. Membuat laporan pengusulan pemusnahan 3. Membuat Berita Acara pemusnahan 4. Melakukan pemusnahan
2. Monev		
1)	Monitoring/ Pemantauan kelancaran SIM-E-RM	1. Rapat unit 2. Rapat insidentil 3. Rapat koordinasi antar unit 4. Rapat dewan/ PT 5. Rapat kerja tahunan
2)	Evaluasi/ Rapat	1. Membuat pelaporan internal 2. Membuat pelaporan eksternal : a) SIRS online dan SIRS jatim b) RS Online c) Aplikasi Dinkes kab malang d) SIHA e) E-Sismal f) SITB



		g) Simkes (dbd) h) SiHepi i) aplikasi kemenkes yang lain j) SKDR k) Sutera Emas (Pelaporan kasus penyakit PD3i)
3)	Pelaporan	1. Membuat pelaporan internal 2. Membuat pelaporan eksternal : a) SIRS online dan SIRS jatim b) RS Online c) Aplikasi Dinkes kab malang d) SIHA e) E-Sismal f) SITB g) Simkes (dbd) h) SiHepi i) aplikasi kemenkes yang lain j) SKDR k) h) Sutera Emas (Pelaporan kasus penyakit PD3i)
3. MFK		
1)	Pemeliharaan alat	1. Memantau pemeliharaan alat oleh IPSRS: a. AC b. Printer c. Komputer d. Scan 2. Melakukan pemeliharaan-kebersihan setiap hari oleh unit 3. Melaporkan jika ada kendala ke sim.ipsrs
2)	Kalibrasi	1. Komputer (2 set) 2. Scanner 1
3)	Penambahan alat	1. mengajukan penggantian 1 monitor komputer yang lebih besar,pengajuan 1 CPU .
4)	Penggantian alat yang saat ini	Pergantian CPU 1
4. K3RS		
	Pelaporan dan Pemantauan k3	1. Pemantauan dan laporan MCU
		2. Pemantauan dan laporan Immunisasi
		3. Pemantauan dan laporan PMT
		4. Pemantauan dan laporan Konseling
		5. Pemantauan mangkir kerja
		6. Pemantauan dan laporan
		7. Pemantauan dan pelaporan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja
5. PMKP (Mutu)		



	Indikator mutu	1. Efektifitas SIMRS dalam upaya menunjang peningkatan mutu rumah sakit
		2. Angka kelengkapan rekam medik rawat inap
		3. Keterlambatan Pengumpulan DRM pasien rawat inap lebih dari 24 jam
		4. Angka kejadian nomor rekam medis ganda
		5. Kelengkapan keakuratan pada penginputan data pasien di SIMRS
		6. Angka keterbacaan dokumen rekam medis
6. PPI		
	Praktek dan Pelaporan	1. Cuci Tangan
		2. Etika Batuk
7. KE (Komunikasi Efektif) - PKRS		
	Edukasi	1. Edukasi Individu General konsen dan HPK
		2. Edukasi Kelompok
		3. Edukasi massa : Banner, Poster, Radio, Medsos
8. SKP		
1	Identifikasi Pasien	Verifikasi 2 identitas pasien (nama, tgl lahir/nomor RM) pada pendaftaran dan pelayanan.
2.	Komunikasi Efektif	Memberikan KIE dan memastikan informasi antar-unit tersampaikan dengan benar
3.	Keamanan Dokumen	Menjaga kerahasiaan dan keamanan DRM (manual dan elektronik)
4.	Pencegahan data ganda	Audit nomor RM dan perbaikan data
5.	Pencegahan infeksi	1. Cuci tangan sebelum/ sesudah handling DRM manual
		2. Menerapkan etika batuk
9. HPK		
1.	Edukasi HPK	1. Memberikan general concent dan edukasi HPK kepada pasien/keluarga
		2. Menyediakan leaflet & media informasi
2.	Perlindungan privasi dan kerahasiaan	Menjaga kerahasiaan data rekam medis dan tidak memberi data pasien tanpa izin resmi
3.	Informasi layanan	1. Menjelaskan alur pendaftaran dan penggunaan rekam medis



		2. Memberikan surat control dan ringkasan medis yang diperlukan ketika pasien keluar rumah sakit
10. MRMIK		
1.	Pendaftaran dan Pencatatan	Verifikasi identitas, input SIMRS, dan penerbitan no RM.
2.	Pengelolaan DRM	1. Assembling DRM manual
		2. Audit kelengkapan E-RM rawat jalan dan rawat inap
		3. Coding
		4. Sentralisasi/penyimpanan dokumen ke dalam rak
3.	Coding	Memberikan kode diagnosa & tindakan sesuai standar.
4.	Penyimpanan dan Retensi	Filing, penyimpanan digital (SIMRS), retensi & pemusnahan DRM.
5.	Pelaporan dan statistik	Membuat laporan RL bulanan dan tahunan, SIRS, RS online, Dinkes dan Prognas.
6.	Review dan Mutu RM	Review open/close RM, audit RM ganda, evaluasi indicator mutu
7.	Sistem Informasi	Pengoperasian SIMRS, akses penunjang, integrasi Satu Sehat

Pengembangan Pelayanan	Rincian Pelayanan
Penggunaan SIMRS RM-e 1. RM-E rawat inap	1. Pembaharuan vitur sistem informasi rumah sakit secara berkala berdasarkan kebutuhan agar tercapainya sistem informasi yang valid dan terintegrasi. 2. Proses pengembangan Pelayanan RM Elektronik adalah pelayanan kesehatan dengan pencatatan rekam medis berbasis elektronik di seluruh unit pelayanan di Rumah Sakit. 3. Memaksimalkan memasukan DRM yang belum memakai RM-e (hard copy yang ada di rak) di masukan ke dalam sistem SIMRS, sehingga rak tidak penuh
1. PDF	1. Penambahan mesin APM Mesin (Anjungan Pendaftaran Mandiri) yang merupakan mesin kiosk digital yang memungkinkan pasien untuk melakukan pendaftaran rawat jalan secara mandiri, tanpa perlu mengantre di loket

3.2. SASARAN

No	Rincian Kegiatan	Tujuan	Sasaran Kegiatan	Jenis	Target/standard	Indikator Keberhasilan	Ket
3.2.1. SDM							
1)	Kebutuhan SDM	Memenuhi kebutuhan SDM sesuai ABK	CSO	usulan	1 untuk shift sore	terpenuhi SDM sesuai ABK	-
2)	Orientasi	SDM baru tahu, mengerti, paham dan terampil ,tupoksi yang harus dilakukan sesuai dengan aturan yg berlaku	Staff Rekam Medis baru	Orientasi	staff rekam medis baru (100%)	Sertifikat,Log Book,Laporan orientasi	Gedung lantai 5 hall sakura
3.2.2. Diklat							
1)	<i>Coding</i>	Meningkatkan kualitas SDM tentang coding	Staff rekam medis 7 orang	Internal	10 orang (100%)	Sertifikat Umandok	-
2)	E-RM (juknis)	Meningkatkan kualitas SDM tentang Juknis ERM	Staff rekam medis 7 orang	Internal	10 orang (100%)	Sertifikat Umandok	-
3)	Pelatihan Etika dan Kerahasiaan Data Pasien	Meningkatkan kualitas SDM RM	Staff rekam medis 7 orang	Internal	10 orang (100%)	Sertifikat Umandok	-
4)	Pelatihan Penggunaan SIMRS	Meningkatkan RM kualitas SDM	Staff rekam medis 7 orang	Internal	10 orang (100%)	Sertifikat Umandok	-



	(Electronic Rekam Medis)						
5)	Pelatihan Audit Internal Rekam Medis dan Evaluasi Data Pasien	Meningkatkan RM kualitas SDM	Staff rekam medis 7 orang	Internal	10 orang (100%)	Sertifikat Umandok	-
6)	Komunikasi efektif KIE pasien	Meningkatkan kualitas SDM Pdf	18 orang pendaftaran	Internal	18 orang (100%)	Kwalitas sdm pdf terpenuhi dengan baik	-
7)	Pelatihan etika dan pelayanan prima	Meningkatkan kualitas SDM Pdf	18 orang pendaftaran	Internal	18 orang (100%)	Penerapan pelayanan prima sesuai SOP	-
8)	Pelatihan Penggunaan SIMRS untuk Pendaftaran Pasien	Meningkatkan kualitas SDM Pdf	18 orang pendaftaran	Internal	18 orang (100%)	Mampu menggunakan SIMRS dengan baik	-
9)	Pelatihan Komunikasi dan Handling Complaint Pasien di Front Office	Meningkatkan kualitas SDM Pdf	18 orang pendaftaran	Internal	18 orang (100%)	Petugas mampu menangani komplain sesuai alur	-
10)	Pelatihan Penerapan Electronic Rekam Medis (ERM) di Loker Pendaftaran	Meningkatkan kualitas SDM Pdf	18 orang pendaftaran	Internal	18 orang (100%)	Pendaftaran menerapkan ERM 100%	-
11)	PPI dasar	Meningkatkan kualitas SDM	22 staf	Internal	22 orang (100%)	Mampu menerapkan PPI dasar (Hand	-



						Hygiene, APD, dll.)	
12)	PMKP (Mutu)	Meningkatkan kualitas SDM	22 staf	Internal	22 orang (100%)	Memahami mutu dan melakukan pelaporan jika di temukan	-
13)	MFK-K3 (BHD,APAR,B3, CODE RED, CODE BLUE)	Meningkatkan kualitas SDM	22 staf	Internal	22 orang (100%)	Bisa memahami 100%	-
14)	KE-PKRS	Meningkatkan kualitas SDM	22 staf	Internal	22 orang (100%)	Meningkatkan dan melakukan komunikasi efektif	-
15)	SKP	Meningkatkan kualitas SDM	22 staf	Internal	22 orang (100%)	Staf memahami 6 SKP & menerapkan dalam pelayanan	-
16)	HPK	Meningkatkan kualitas SDM	22 staf	Internal	22 orang (100%)	Staf mampu menjelaskan hak pasien & menerapkannya	-
17)	MRMIK	Meningkatkan kualitas SDM	22 staf	Internal	22 orang (100%)	Staf memahami standar MRMIK, alur RM, keamanan data	-
3.2.3. Monev							



1)	Evaluasi kinerja	Mampu membantu pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) ke tingkat yang lebih optimal	Semua staff rekam medis	Pelatihan	Staff rekam medis (100%)	Log Book,Laporan evaluasi kinerja	Ruang masing-masing
3.2.4. PELAYANAN RM + PENDAFTARAN							
1)	Identifikasi pasien	Memastikan keselamatan dan keamanan pasien	Semua staff PDF	SKP	100% pasien teridentifikasi	Evaluasi kinerja baik supervisi	Ruang pendaftaran dan seluruh pendaftaran rekam medis
2)	KIE Pasien& keluarga	Meningkatkan pengetahuan Pasien dan keluarga	Semua Pasien dan keluarga	KIE	100% pasien mendapat KIE	Evaluasi kinerja baik	HPK General Konsen tarip-kelas- DPJP asuhan
3.2.5. MFK							
1)	Pemeliharaan Alat	Memastikan alat di unit tidak ada kendala	Semua staff rekam medis dan pdf	Internal	Seluruh staff rekam medis	Tidak ada kendala pada alat alat di ruang rekam medis dan pdf	Di ruang rekam medis dan PDF
2)	Kalibrasi	Memastikan alat di unit tidak ada yang terkendala	Semua staff rekam medis dan pdf	Internal	semua terkalibrasi	Tidak ada kendalan dan alat alat di ruang rekam medis dan	-



						pdf dalam kondisi baik	
3)	Perbaikan	Memastikan alat di unit tidak ada yang terkendala	Semua staff rekam medis dan pdf	Internal	100% dalam kondisi baik	Tidak ada kendalan dan alat alat di ruang rekam medis dan pdf dalam kondisi baik	-
4)	Pengadaan	Memenuhi kebutuhan di ruangan	Semua staff rekam medis dan pdf	Internal	100% terpenuhi	Semua kebutuhan terpenuhi	-
5)	Pemeliharaan Ruang	Memastikan ruangan baik dan bersih	Semua staff rekam medis dan pdf	Internal	80% terpelihara dengan baik	Tidak ada kerusakan maupun kendala di ruangan, serta terjaga dengan baik	-
3.2.6. K3RS							
1)	Pemantauan dan laporan MCU	Mencegah penularan penyakit	Semua staff rekam medis dan pdf	Internal	Seluruh staff rekam medis	Semua staff melakukan MCU agar kesehatan termonitor dengan baik	Hall / poli
2)	Pemantauan dan laporan Immunisasi	Mencegah penularan penyakit	Semua staff rekam medis dan pdf	Internal	Seluruh staff rekam medis	Semua staff mengikuti vaksin lengkap	poli
3)	Pemantauan dan laporan PMT	Mencegah penularan penyakit	Semua staff rekam medis dan pdf	Internal	Seluruh staff rekam medis	Semua staff terpantau	-



5)	Pemantauan mangkir kerja	Mencegah kecurangan bekerja	Semua staff rekam medis dan pdf	Internal	100% mematuhi peraturan	Semua staf masuk di jam kerja sesuai dengan SK tatib dan tidak mangkir.	Finger sdm
6)	1. Pemantauan dan laporan 2. Penggunaan masker (APD)	Mencegah penularan penyakit	Semua staff rekam medis dan pdf	Internal	100% menggunakan APD pada saat mendaftar	Rekam medis dan pdf paham 100%	Seluruh staf rekam medis
7)	Pemantauan dan pelaporan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja	Memastikan tidak terjadinya tertimpa alat berat seperti tangga dan dokumen rekam medis	Semua staff rekam medis dan pdf	Monev	0%/ tidak kejadian	100% staf patuh bukti supervisi	Ruang rekam medis blok 1,2 dan dpm
3.2.7 PMKP (MUTU)							
RM							
1)	Angka kelengkapan Rekam Medis Pasien Rawat Inap	Meningkatkan kelengkapan dokumen rekam medis	Petugas RM dan PPA	Pelaporan dan supervisi	100%	Audit kelengkapan dokumen rekam medis rawat inap	SIMRS
2)	Angka kejadian nomor rekam medis ganda	Mencegah dobel RM	Seluruh staff pendaftaran	Pelaporan dan supervisi	0%	Tidak ada duplikasi nomor RM	SIMRS
3)	Keterlambatan Pengumpulan DRM	Menekan keterlambatan pengembalian	Petugas RM dan PPA (Perawat)	Supervisi dan monitoring	0%	Bukti audit mutu	SIMRS



	Pasien Rawat Inap Lebih Dari 1x24 jam	dokumen rekam medis					
PDF							
1)	Angka kejadian pasien tidak di SEP	Klaim BPJS	Pasien BPJS	Pelaporan dan supervisi	100% pasien BPJS ada SEP	SEP 100 Pasien BPJS Klaim BPJS diterima 100%	Simrs
2)	Kelengkapan dan keakuratan pada penginputan data pasien di SIMRS	Meningkatkan kelengkapan rumah sakit	Seluruh staff Rekam Medis dan PDF	Observasi supervisi	Mencapai standar yang ditetapkan oleh Tim Mutu	Semua data pasien lengkap 100%	Simrs
3.2.8. PPI							
1)	Cuci tangan	Meningkatkan pelayanan di rumah sakit	Seluruh staff Rekam Medis dan PDF	Praktek ,Pelaporan dan supervise	Mencapai standar yang ditetapkan oleh Tim PPI.	Indikator PPI Unit	Ruang masing- masing
2)	Etika batuk	Meningkatkan pelayanan di rumah sakit	Seluruh staff Rekam Medis dan PDF	Praktek, Pelaporan dan supervisi	Mencapai standar yang ditetapkan oleh Tim PPI.	Indikator PPI Unit	Ruang masing- masing
3.2.9. KE - PKRS							
1)	Pemberian KIE individu	Sampainya KIE ke pasien dengan baik dan benar	Semua staf	Praktek,tur un langsung, dokumenta si dan materi	100% pasien & keluarga	Form HPK Form GC lengkap dan hasil verifikasi 100% benar	-



2)	Pemberian Kelompok / pemberian KIE masa	Komunikasi efektif antar staf dan pasien bisa terlaksana dengan baik	Satf dan pasien	Praktek,turun langsung,diskuis kelompok umadnok	100% berkomunikasi dengan baik	Umandok	-
3.2.10 SKP							
1)	Penerapan Identifikasi Pasien (SKP 1)	Menjamin ketepatan identitas pasien	Seluruh staff Rekam Medis dan PDF	Observasi dan Supevisi	100% pasien menggunakan 2 identitas	Tidak ada kesalahan identifikasi pasien	-
2)	Peningkatan Komunikasi Efektif (SKP 2)	Memastikan komunikasi efektif	Seluruh staff Rekam Medis dan PDF	Pelatihan dan Supervisi	100% staf menerapkan read back/verbal order	Bukti audit komunikasi efektif	-
3)	Pengelolaan Obat Risiko Tinggi (SKP 3)	Menjamin keamanan obat high alert	Staf terkait input & distribusi data	Supervisi	100% obat risiko tinggi ditandai & dicatat	Audit obat high alert	-
4)	Tepat Pasien, Prosedur, Lokasi Operasi (SKP 4)	Mendukung proses pre-tindakan sesuai prosedur	Staf rekam medis (pengelolaan berkas & informed consent)	Supervisi	100% berkas lengkap sebelum tindakan	Tidak ada kesalahan prosedur akibat berkas RM	-
5)	Pengurangan Risiko Infeksi (SKP 5)	Mencegah infeksi melalui PPI	Seluruh staff Rekam Medis dan PDF	Observasi	100% patuh 5 momen cuci tangan	Audit PPI unit	-
6)	Pencegahan Risiko Pasien Jatuh (SKP 6)	Mendeteksi risiko jatuh sejak pendaftaran	PDF	Supervisi	0% asesmen risiko jatuh terinput	Laporan risiko jatuh 0%	-
3.2.11 HPK							



1)	Edukasi Hak Pasien dan Keluarga	Memastikan pasien mengetahui hak dan kewajibannya	Semua pasien dan keluarga	KIE dan Supervisi	100% diberikan edukasi	Form HPK lengkap & terverifikasi	-
2)	Penyediaan Informasi General Consent	Memastikan pasien paham sebelum tandatangan	Pasien dan keluarga	Observasi dan verifikasi	100% pasien diberikan GC	GC lengkap & tersimpan dalam SIMRS	SIMRS
3)	Penguatan Komunikasi Efektif (HPK)	Menjamin komunikasi jelas dan mudah dipahami	Seluruh staff Rekam Medis dan PDF	Pelatihan	100% staf kompeten	Evaluasi kompetensi komunikasi meningkat	-
4)	Perlindungan Privasi dan Kerahasiaan Data	Memastikan RM aman dan privasi terjaga	Petugas RM	Supervisi	100% staf patuh	Tidak ada insiden kebocoran data	-
3.2.12 MRMIK							
1)	Pengelolaan Kelengkapan Berkas RM	Menjamin kelengkapan RM	Petugas RM	Supervisi	100% RM lengkap	Audit kelengkapan RM 100%	-
2)	Keamanan dan kerahasiaan Rekam Medis	Melindungi data pasien	Petugas RM	Monitoring	100% penyimpanan sesuai SOP	Tidak ada insiden pelanggaran data	-
3)	Penguatan penerapan ERM	Optimalisasi SIMRS / ERM	Seluruh staff Rekam Medis dan PDF	Pelatihan	100% staf menguasai	Penginputan data akurat 100%	-
4)	Pelaporan Statistik Rumah Sakit	Menyediakan data yang a	Petugas RM	Pelaporan	100% tepat waktu	Laporan valid & sesuai standar SIRS	-

3.5. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN



No	Rincian Kegiatan	Cara Melaksanakan Kegiatan	Metode	Media	Jadwal	Bukti Pelaksanaan	Ket
SDM							
1	Orientasi	1. Koordinasi dengan SDM 2. Orientasi staff baru rekam medis sesuai dengan Jadwal dan Regulasi yang berlaku. 3. Menyiapkan agenda serta materi atau soal yang akan di beri oleh pegawai orientasi di setiap harinya 4. Menjelaskan alur rs dan unit 5. Membikin log book 6. Menjelaskan regulasi unit 7. Memberikan tugas harian sesuai dengan jobdisk di unit rekam medis dan pendaftaran serta di beri target .	CJT praktek simulasi penugasan	Log book Komputer HP	Saat penerimaan staff baru	Log book sertifikat evaluasi kinerja orientasi	-
2	Diklat	1. Persiapan (perencanaan): a. Mengajukan TOR ke bagian Manajemen sesuai dengan kebijakan serta menunggu acc 2. Pelaksanaan Diklat: a. Melaksanakan kegiatan diklat 3. Evaluasi Pasca diklat: a. Mengirimkan nota dinas ke bagian manajemen	CJT praktek simulasi penugasan Roll Play Game	LCD Zoom Laptop PC	1 th , 1 kali	Sertifikat Umandok	-



3	Evaluasi Kinerja	1. Membuat analisis beban kerja unit sesuai dengan jobdisk 2. Diserahkan ke bagian manajemen 3. Penyusunan dan edukasi kriteria penilaian yang akan menjadi tolak ukur dari hasil evaluasi kinerja 4. Penilaian hasil dari performa kerja selama 1 bulan sekali. 5. Pembuatan laporan hasil evaluasi kinerja 6. Menentukan target lagi pada bulan berikutnya	Evaluasi ,pelaporan dan tindak lanjut	Log book	1 bulan sekali (diakhir bulan)	Log book	-
4	Pelayanan RM dan pendaftaran						
	1. Identifikasi pasien	1. Lakukan pelatihan tentang cara identifikasi pasien 2. Pantau praktek dan memastikan keselamatan dan keamanan pasien 3. Laporkan setiap insiden keselamatan pasien dan lakukan evaluasi	Pelatihan dan pelayanan	Praktek dan log book	Pelatihan saat orientasi karyawan baru 3 bulan ,1 kali. Review selama 6 bulan untuk karyawan lama	Sertifikat	-
	2. Peningkatan komunikasi yang efektif	1. Lakukan pelatihan komunikasi efektif 2. Pantau praktek komunikasi efektif	Pelatihan dan pelayanan	Praktek dan log book	Pelatihan saat orientasi karyawan baru 3 bulan ,1 kali. Review selama 6 bulan untuk karyawan lama	Sertifikat	-



MFK							
1	Pencegahan dan pengendalian kebakaran dokumen rekam medis	Pelatihan internal oleh tim MFK yang diikuti oleh unit rekam medis dan PDF	Pelatihan	praktek	Review selama 6 bulan 1 kali	Uamandok	-
2	Pemeliharaan Alat	1. Pemeliharaan alat di unit masing masing 2. Jika ada kendala menginput di sim ipsrs	Pemeliharaan alat	pelayanan	Setiap hari	Log book	-
K3RS							
1	Pemakaian Alat Pelindung Diri (APD)	1. Lakukan pelatihan keselamatan dan keamanan kerja 2. Sediakan alat pelindung diri dan fasilitas untuk keselamatan kerja 3. Pantau praktek keselamatan dan keamanan kerja seperti tergores kertas, terkena benda steples atau remover serta terkena paparan debu 4. Lakukan evaluasi	praktek	Pelatihan	Review selama 6 bulan 1 kali, (dilakukan setiap hari)	Umandok	-
2	Terpapar Penyakit	1. Lakukan pelatihan keselamatan dan keamanan kerja 2. Sediakan alat pelindung diri dan fasilitas untuk keselamatan kerja 3. Lakukan evaluasi	praktek	pelatihan	Review selama 6 bulan 1 kali, (dilakukan setiap hari)	Umandok	-
3	Tertimpa alat berat (tangga dan dokumen)	1. Sosialisasi setiap hari agar berhati-hati dalam bekerja dan menggunakan tangga saat mengambil DRM di rak 2. Maintance tangga jika memang ada kerusakan 3. Lakukan evaluasi	praktek	Monitoring dan evaluasi	Review selama 6 bulan 1 kali, (dilakukan setiap hari)	Umandok	-
PMKP (MUTU)							



1	Angka kelengkapan rekam medis pasien rawat inap	1. Melakukan pemeriksaan kelengkapan DRM pasien rawat inap setelah closing. 2. Memberikan reminder kepada PPA apabila terdapat berkas yang belum lengkap. 3. Follow up PPA untuk penyelesaian berkas tidak lengkap. 4. Input hasil monitoring ke SIMRS	Audit dokumen rekam medis	Review hasil evaluasi bulanan dan supervisi	Harian & Rapat evaluasi bulanan	Form audit DRM & Log book	-
2	Angka kejadian nomor rekam medis ganda	1. Melaporkan keunit RM jika ada dobel rm 2. Menindak lanjuti input ke simrs 'di menu penggabungan nomer rekam medis' 3. Input simrs terkait temuan dobel DRM di Mutu 4. Lakukan evaluasi	Praktek	Monitoring dan evaluasi	Dilakukan rapat 1 bulan sekali. Dilakukan Setiap hari	Log book	-
3	Keterlambatan pengumpulan DRM pasien rawat inap lebih dari 1x24 jam	1. Monitoring DRM pasien yang telah pulang melalui SIMRS. 2. Memberikan pemberitahuan ke ruangan bila ada keterlambatan DRM. 3. Melaporkan ke penanggung jawab ruangan jika keterlambatan berulang. 4. Lakukan evaluasi	Praktek	Monitoring dan evaluasi	Harian & Rapat evaluasi bulanan	Log book	-
3	Angka kejadian pasien tidak di SEP	1. Membuat kronologi di serahkan ke pihak manajemen 2. RTL dari manajemen terkait 'tidak ter SEP nya pasien' 3. Lakukan monev dan penilaian di masukan ke evaluasi kinerja	Pelatihan dan praktek	Monitoring dan evaluasi	Dilakukan rapat 1 bulan sekali. Dilakukan Setiap hari	Log book	-
4	Kelengkapan dan keakuratan pada penginputan data pasien di SIMRS	1. Melakukan review penginputan data simrs 2. Masuk di evaluasi kinerja 3. Lakukan monev	praktek	Monitoring dan evaluasi	Dilakukan rapat 1 bulan sekali. Dilakukan Setiap hari	Log book	



PPI							
1	Cuci tangan	1. Koordinasi dengan Tim PPI RS 2. Melakukan monitoring, evaluasi setiap bulannya dengan pj PPI	Pelatihan	Pelaporan dan supervisi	Review selama 6 bulan 1 kali, (dilakukan 1 minggu 3 kali supervisi oleh PJ PPI)	Pelaporan dan dokumentasi	-
2	Etika batuk	1. Koordinasi dengan Tim PPI RS 2. Melakukan monitoring, evaluasi setiap bulannya dengan pj PPI	Pelatihan	Pelaporan dan supervisi	Review selama 6 bulan 1 kali, (dilakukan 1 minggu 3 kali)	Pelaporan dan dokumentasi	-
KE - PKRS							
1	Promo kesehatan	1. Pelaporan hasil dari 10 besar penyakit 2. Follow up ke bagian tim PKRS terkait penyakit yang di nilai teratas	Promosi kesehatan	Pelaporan	1 bulan sekali (2 minggu sekali (senam geriatri, senam hamil)	Pelaporan	-
2	Komunikasi Efektif	1. Pelatihan komunikasi efektif 2. Penerapan read back/verbal order 3. Monitoring	Pelatihan, Simulasi	Simulasi SOP Komunikasi, log book	Review 3 bulan & monitoring harian	Form monitoring komunikasi	-
SKP							
1.	Identifikasi Pasien (SKP 1)	1. Pelatihan 2 identitas pasien 2. Supervisi harian 3. Audit ketepatan identifikasi	Pelatihan, Praktek, Audit	Log book, Form audit SKP	Setiap hari & evaluasi 1 bulan sekali	Form audit SKP, laporan identifikasi	-
2.	Komunikasi Efektif (SKP 2)	1. Pelatihan komunikasi efektif 2. Penerapan read back/verbal order 3. Monitoring	Pelatihan, Simulasi	Simulasi SOP Komunikasi, log book	Review 3 bulan & monitoring harian	Form monitoring komunikasi	-



3.	Pengelolaan Obat High Alert (SKP 3)	1. Identifikasi obat high alert 2. Edukasi staf 3. Monitoring obat	Edukasi, Supervisi	Daftar obat high alert	3 bulan sekali	Laporan obat high alert	-
4.	Tepat Pasien, Tepat Lokasi, Tepat Prosedur (SKP 4)	1. Review berkas RM pra-tindakan 2. Supervisi GC 3. Audit kelengkapan RM	Supervisi, Audit	Check list pra-tindakan	Harian & evaluasi bulanan	Form pra- tindakan lengkap	-
5.	Pencegahan Risiko Infeksi (SKP 5)	1. Pelatihan PPI 2. Monitoring cuci tangan 3. Audit APD	Pelatihan, Praktek	Form PPI	Harian & review 6 bulan	Form PPI, dokumentasi	-
6.	Pencegahan Risiko Pasien Jatuh (SKP 6)	1. Asesmen risiko jatuh 2. Monitoring gelang risiko jatuh 3. Edukasi staf	Edukasi, Observasi	Form asesmen risiko jatuh	Harian	Form asesmen lengkap	-
HPK							
1.	Edukasi Hak Pasien & Keluarga	1. Edukasi HPK saat pendaftaran 2. Penjelasan alur pelayanan 3. Memberikan kesempatan bertanya	KIE, Sosialisasi	Form HPK, Leaflet	Setiap hari	Form HPK lengkap	-
2.	General Consent (GC)	1. Menjelaskan isi GC 2. Verifikasi pemahaman pasien 3. Penyimpanan GC di SIMRS	KIE, Observasi	Form GC, SIMRS	Setiap hari	GC lengkap 100%	-
3.	Privasi & Kerahasiaan Data	1. Menjaga kerahasiaan data 2. Pembatasan akses RM 3. Edukasi staf	Monitoring	SOP	Setiap hari	Laporan kerahasiaan data	-
4.	Komunikasi Efektif Pasien– Staf	1. Edukasi staf 2. Observasi praktik komunikasi 3. Evaluasi bulanan	Pelatihan, Role Play	SOP, Log book	Setiap hari	Laporan evaluasi	-
MRMIK							
1.	Kelengkapan Rekam Medis	1. Audit RM harian 2. Supervisi RM 3. Input hasil audit ke SIMRS	Audit & Supervisi	RM, checklist kelengkapan	Harian & bulanan	Laporan audit RM	-
2.	Keamanan & Kerahasiaan RM	1. Penyimpanan aman 2. Kontrol akses 3. Edukasi kerahasiaan	Monitoring	SOP, RM	Setiap hari	Laporan keamanan	-



3.	Pemanfaatan SIMRS/ERM	1. Pelatihan SIMRS 2. Monitoring input data 3. Evaluasi akurasi	Pelatihan & Evaluasi	SIMRS, laptop	Harian & rapat bulanan	Data akurat 100%	-
4.	Pelaporan Statistik RS	1. Rekap data 2. Input SIRS 3. Pelaporan ke Manajemen	Pelaporan	SIMRS, Excel	Bulanan	Laporan SIRS	-

Berikut merupakan cara melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja instalasi rekam medis yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

3.6. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUN 2026

NO	RINCIAN KEGIATAN	SASARAN	BULAN												TEMPAT	PIC	SUMBER DANA	KET
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	SDM:																	
	a. Orientasi Khusus Staf Baru Rekam medis	Staff baru			v						v				Hall sakura	Karu	Rs Prima Husada	Dilakukan orientasi jika ada pegawai baru
	b. Diklat	Semua staff				v					v				Luar RS	SDM	Rs Prima Husada	Diklat eksternal dan internal
	c. Evaluasi Kinerja	Semua staff RM dan PDF	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Ruang rm dan pdf	Kepala ruangan	Rs Prima Husada	Evaluasi kinerja dilakukan pencatatan setiap hari dan di masukan ke nilai evaluasi kinerja
2	Pelayanan rm dan pdf	Semua staff RM dan PDF	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Ruang rm dan pdf	Kepala ruangan	Rs Prima Husada	Pelayanan sesuai alur



3	MFK	Semua staff RM			v										Hall sakura	Kepala MFK	Rs Prima Husada	Pelaksanaan berkala
4	K3RS	Semua staff RM				v									Hall sakura	Kepala K3	Rs Prima Husada	Dilakukan setiap hari jika terjadi k3rs di laporkan di mutu
5	MUTU	Semua staff RM dan PDF	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	SIMRS	PIC data Mutu unit dan PJ mutu	Rs Prima Husada	Setiap hari dilakukan pencatatan
6	PPI	Semua staff RM dan PDF					v								Hall sakura	Kepala PPI dan PJ Ppi	Rs Prima Husada	Dilakukan seminggu 3 untuk refresh cuci tangan dan etika batuk oleh PJ PPI
7	KE-PKRS	Semua staff RM dan PDF								v	v	v			Hall sakura	Kepala PKRS	Rs Prima Husada	Dilakukan penyuluhan oleh petugas perawat atau pun gizi, dari data penarikan 10 besar penyakit
8.	SKP	Semua staff RM dan PDF							v						Hall sakura	Pokja SKP	Rs Prima Husada	Refresh materi SKP
9.	HPK	Semua staff RM dan PDF						v							Hall sakura	Pokja HPK	Rs Prima Husada	Edukasi HPK
10.	MRMIK	Semua staff RM dan PDF			v	v									Hall sakura	Pokja MRMIK	Rs Prima Husada	Evaluasi & pendampingan terkait MRMIK



3.7. Kebutuhan Anggaran

Semua anggaran akan dibiayai dari anggaran RSPH Malang yang telah disetujui oleh PT.DPM

Contoh : Perhitungan biaya berdasarkan pemakaian rata -rata perbulan adalah sebagai berikut:

NO	BAHAN	RATA/BL	KEBUTUHAN 1 TH		HARGA SATUAN	TOTAL	KET
			Jumlah	Satuan			
1	HANDWASH	2	24	Botol	Rp. 30.000	Rp. 720.000	PPI
2	Tisu	4	48	Pcs	Rp. 7.000	Rp. 336.000	PPI
3	Kertas	7	84	Rim	Rp. 40.000	Rp. 3.360.00	Gudang Umum
4	Stiki note	5	60	Pcs	Rp. 7.000	Rp. 420.000	Gudang Umum
5	Bulpoin	5	60	Pcs	Rp. 3.000	Rp. 180.000	Gudang Umum
6	Remover	1	12	Pcs	Rp. 5.000	Rp. 60.000	Gudang Umum
7	Steples	1	12	Pcs	Rp. 10.000	Rp. 120.000	Gudang Umum
8	Isi staples	1	12	box	Rp. 70.000	Rp. 840.000	Gudang Umum
9	Tinta printer	2 (hitam)	24	Botol	Rp. 80.000	Rp. 1.920.000	Gudang Umum
10	Tinta spidol	1	12	Botol	Rp. 25.000	Rp. 300.000	Gudang Umum
11	Stabilo	1	12	Pcs	Rp. 10.000	Rp. 120.000	Gudang Umum
12	Perforator	1 = 3 bulan sekali	4	Pcs	Rp. 50.000	Rp. 200.000	Gudang Umum
13	Solasi	1	12	Pcs	Rp. 3000	Rp. 36.000	Gudang Umum
14	Map L Bening	6	72	Pcs	Rp. 1.500	Rp. 108.000	Gudang Umum



NO	RINCIAN KEGIATAN	INTERNAL/EKSTERNAL	JUMLAH SATUAN	HARGA SATUAN	TOTAL Rp	KET
SDM						
1.	<i>Inhouse training</i> wajib di Rumah Sakit (BHD, PPI Dasar, PMKP, Komunikasi Efektif)	Internal	1	Rp. 500.000	Rp. 500.000	SDM
2.	Pelatihan Koding	Eksternal	1	Rp. 500.000	Rp. 500.000	SDM
3.	<i>Pelatihan program RM-E</i>	Internal	1	Rp. 400.000	Rp. 400.000	SDM
4.	Pelatihan Etika dan Kerahasiaan Data Pasien	Internal	1	Rp. 300.000	Rp. 300.000	SDM
5.	Pelatihan Penggunaan SIMRS (Electronic Rekam Medis)	Internal	1	Rp. 500.000	Rp. 500.000	SDM
6.	Pelatihan Audit Internal Rekam Medis dan Evaluasi Data Pasien	Internal	1	Rp. 350.000	Rp. 350.000	SDM
7.	Komunikasi efektif KIE pasien	Internal	1	Rp. 250.000	Rp. 250.000	SDM
8.	Pelatihan etika dan pelayanan prima	Internal	1	Rp. 450.000	Rp. 450.000	SDM
IT & IPSRS						
1.	Perencanaan Rekam Medis Elektronik			-	Rp. 150.000.000	PENGADAAN
2.	Komputer set	Fasilitas	1	Rp. 5.000.000	Rp. 10.000.000	PENGADAAN
3.	Scanner	Fasilitas	1	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000	PENGADAAN
4.	Tab (Finger rawat Inap)	Fasilitas	1	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000	PENGADAAN

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Jadwal kegiatan tersebut akan dievaluasi setiap satu bulan sekali, sehingga bila dari evaluasi diketahui ada pergeseran / penyimpangan jadwal dapat segera diperbaiki sehingga tidak mengganggu program secara keseluruhan. Evaluasi jadwal kegiatan tersebut dilakukan oleh kepala Instalasi Rekam Medis. Laporan evaluasi skedul (jadwal) kegiatan dibuat setiap satu bulan sekali dimasukkan kedalam laporan Rekam Medis dan ditujukan kepada Direktur Rumah Sakit.

Untuk Monitoring dan evaluasi Program Kerja Instalasi Rekam Medis Rumah sakit Prima Husada merumuskan dan menyusun kebijakan untuk menjamin mutu pelayanan di Rumah Sakit Prima Husada dengan membuat program pengendalian dan peningkatan untuk mutu tersebut. Perumusan dan penyusunan kebijakan pengendalian dan peningkatan mutu pelayanan dilakukan berdasarkan hasil evaluasi melalui masukan dari seluruh jajaran dan staf yang terlibat dan berdasarkan hasil evaluasi kinerja secara periodik yang kemudian ditindaklanjuti untuk dilaporkan kepada direksi.

Kegiatan dalam upaya pengendalian dan peningkatan mutu pelayanan dapat dilakukan melalui :

1. Studi Dokumentasi
Merupakan salah satu metode untuk melihat sejauh mana penerapan standar yang dilakukan oleh karyawan dan staf
2. Pembahasan kotak saran
Merupakan salah satu metode untuk membahas permasalahan dalam pengelolaan pelayanan asuhan pada pasien dengan kasus-kasus tertentu yang jarang terjadi
3. Survey Kepuasan Pasien
Suatu kegiatan untuk mendapatkan masukan dari pasien atau keluarga pasien mengenai persepsi pasien terhadap mutu pelayanan di Rumah Sakit melalui pengisian kuesioner oleh pasien atau keluarga pasien
4. Audit pasien atau pembahasan kasus
Merupakan salah satu metode untuk membahas permasalahan dalam pengelolaan pelayanan asuhan pasien dengan kasus-kasus tertentu yang jarang terjadi
5. Supervisi
Suatu kegiatan pemantauan, pengawasan dan penilaian terhadap seluruh kegiatan di ruangan dalam pelaksanaan pelayanan di rumah sakit mulai dari sikap, pengetahuan dan ketrampilan sebagai bahan untuk peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia dan mutu pelayanan
6. Laporan kejadian
Proses pembahasan kejadian pelanggaran etika profesi. Dibuatkan laporan kronologis kejadian untuk kemudian dilakukan kajian, Analisa dan klarifikasi data serta pembinaan terhadap yang bersangkutan. Tindak lanjut dari laporan kejadian ini dapat berupa pelatihan, pendampingan, pembuatan usulan prosedur dan hal teknis lainnya
7. Rapat Rutin
Sebagai sarana pemecahan masalah pelayanan yang terjadi baik secara Teknik operasional maupun Teknik pengelolaan atau manajerial di lingkungan rumah sakit

Pelaksanaan Kebijakan

1. Kebijakan Mutu
Kebijakan mutu yang dilaksanakan berdasarkan kebijakan mutu yang diputuskan oleh Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang yang bersumber dari hasil kerja Komite PMKP atau Tim yang ditunjuk oleh Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang untuk peningkatan mutu pelayanan di Rumah Sakit Prima Husada Malang
2. Kebijakan Kendali Mutu
Untuk pengendalian mutu pelayanan dibuat standarisasi pelayanan dan pembuatan Prosedur tetap pelayanan (SPO) yang disebarakan ke seluruh unit kerja terkait untuk



dijadikan pegangan dalam pelaksanaan pekerjaan serta dibentuk kelompok gugus kengali mutu di setiap unit kerja.

3. Rencana dan Program Kebijakan

Perencanaan dan pembuatan program kebijakan dilaksanakan secara periodik dan dievaluasi minimal setiap 3 bulan, 6 bulan dan satu tahun sekali yang dibicarakan dengan seluruh jajaran struktural

4. Proses dan Evaluasi Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan dievaluasi secara berkala melalui pertemuan rutin jajaran struktural terutama mengenai efektifitas dari pelaksanaan kebijakan tersebut dengan menganalisa seluruh data yang ada yang terdiri dari data utama dan data pendukung

5. Pengawasan dan Evaluasi Kebijakan

Pengawasan dan evaluasi kebijakan dilaksanakan oleh pejabat struktural yang berada pada unit kerja yang bersangkutan dan dilaporkan secara berjenjang kepada pejabat struktural di atasnya.

Hasil pelaksanaan kebijakan dianalisa oleh pejabat struktural yang ada pada unit kerja yang bersangkutan dan dilaporkan kepada atasannya secara periodik untuk dilaksanakan perbaikan sebagai upaya tindak lanjut sesuai kebutuhan unit kerja yang bersangkutan

BAB V

PENCATATAN DAN PELAPORAN

Pencatatan dan pelaporan program kerja dimaksudkan untuk mendapatkan laporan secara cepat, tepat dan akurat. Sistem pelaporan di Rumah Sakit Prima Husada Malang memakai tata cara desentralisasi dimana sistem pelaporan tidak terkoordinasi hanya lewat satu pintu tetapi masing-masing unit/ ruang bisa langsung melakukan pelaporan dengan menggunakan buku ekspedisi.

Adapun jenis pelaporan yang ada di Rumah Sakit Prima Husada Malang dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu :

1. Laporan Internal Rumah Sakit

Yaitu laporan yang dibuat sebagai masukan untuk menyusun konsep rancangan dasar sistem informasi manajemen rumah sakit.

Laporan internal rumah sakit meliputi :

- a. Sensus harian
- b. Laporan efisiensi Rumah sakit
- c. Kegiatan pelayanan Medis
- d. Kegiatan pelayanan Penunjang rumah sakit

2. Laporan Eksternal Rumah Sakit

Yaitu pelaporan yang dibuat oleh rumah sakit sesuai dengan peraturan yang berlaku, yang ditujukan kepada pihak eksternal seperti Departemen Kesehatan, Dinas kesehatan Propinsi dan dinas kesehatan kabupaten/kota.

Adapun laporan tersebut meliputi:

- a. Data kegiatan Rumah Sakit
- b. Data keadaan morbiditas pasien rawat inap
- c. Data keadaan morbiditas penyakit khusus rawat inap
- d. Data keadaan morbiditas pasien rawat jalan
- e. Data keadaan morbiditas pasien rawat jalan
- f. Data keadaan morbiditas penyakit khusus pasien rawat jalan
- g. Data individual morbiditas pasien rawat inap
- h. Data Inventaris rumah sakit
- i. Data keadaan ketenagaan
- j. Data peralatan Rumah Sakit

Periode Pelaporan

Periode Laporan dibuat berdasarkan catatan harian yang dikompilasi dan dilaporkan setiap :

1. 1 Bulan sekali (Bulanan):



- a. Dilaporkan ke bagian management melalui google drive (internal)
 - b. Dilaporkan ke PT, dokter aslichah melalui zoom meeting di setiap bulanya (internal)
 - c. Dilaporkan ke dinas kesehatan melalui apliki sirs jatim :
 - 1) RL 3.1 Indikator Pelayanan
 - 2) RL 3.2 Rawat Inap
 - 3) RL 3.3 Rawat Darurat
 - 4) RL 3.4 Pengunjung
 - 5) RL 3.5 Kunjungan
 - 6) RL 3.6 Kebidanan
 - 7) RL 3.7 Neonatal, Bayi dan Balita
 - 8) RL 3.8 Laboratorium
 - 9) RL 3.9 Radiologi
 - 10) RL 3.10 Rujukan
 - 11) RL 3.14 Pelayanan Khusus
 - 12) RL 4.1 Morbiditas Pasien Rawat Inap
 - 13) RL 4.2 10 Besar Penyakit Rawat Inap
 - 14) RL 4.3 10 Besar Kematian Penyakit Pasien Rawat Inap
 - 15) RL 5.1 Morbiditas Pasien Rawat Jalan
 - 16) RL 5.2 10 Besar Kasus Baru Penyakit Rawat Jalan
 - 17) RL 5.3 10 Besar Kunjungan Penyakit Rawat Jalan
 - d. Dilaporkan ke dinas kesehatan (hiv,dbd,hepatitis,malaria, SKDR) melalui aplikasi web yang disediakan dinkes (eksternal)
2. 3 Bulan sekali (Triwulan)
 - a. Review RM-e, Dilaporkan ke bagian kepala tim review
 - b. Dilaporkan ke management
 3. 1 Tahun sekali (Tahunan)
 - a. Dilaporkan ke bagian management sekre
 - b. Dilaporkan ke bagian dinas kesehatan melalui aplikasi sirs jatim :
 - 1) RL 3.11 Gigi dan Mulut
 - 2) RL 3.13 Rehabilitasi Medik
 - 3) RL 3.15 Kesehatan Jiwa
 - 4) RL 3.16 Keluarga Berencana
 - 5) RL 3.17 Farmasi Pengadaan Obat
 - 6) RL 3.18 Farmasi Resep
 - 7) RL 3.19 Cara Bayar



BAB VI PENUTUP

Demikian Program Instalasi Rekam Medis Rumah Sakit Prima Husada Malang Tahun 2026 ini kami susun sebagai acuan dalam pelaksanaan pelayanan di Bidang penunjang Rumah Sakit Prima Husada Malang selama periode kerja tahun 2026.

Kami menyadari dalam penyusunan program kerja ini masih banyak kekurangan sehingga diharapkan adanya kritik dan saran untuk perbaikan selanjutnya

Mengetahui
Kepala Bidang Penunjang

(Dwi Novianti,A.Md.AK,S.Kes)

Malang, 30 November 2025
Kepala Ruang/Instalasi

(Annisa Aulia Savira,A.Md.Kes)

Lampiran RBA tahun 2026
RENCANA BISNIS ANGGARAN UNTUK INSTALASI REKAM MEDIS TAHUN 2026

Tabel 6.2 Rincian Kegiatan Pemenuhan Pengembangan Pelayanan Tahun 2026

NO	Kegiatan	Rincian Kegiatan	Tujuan	Cara Melaksanak an kegiatan	Sasaran	Target Pelaksan aan	Indikator Keberhasilan	Jumlah (satuan)	Jenis	Satuan Harga Rp	Total Usulan Anggaran
1	Penambahan	Penambahan Handwash	Memenuhi kebutuhan RM	Pengajuan Order logistik di simrs	Unit RM	1th	Tersedia dan tercukupi handwash	24	Botol	Rp. 30.000	Rp. 720.000
2	Penambahan	Penambahan Tisu	Memenuhi kebutuhan RM	Pengajuan Order logistik di simrs	Unit RM	1th	Tersedia dan tercukupi ersedianya Tisu	48	Pcs	Rp. 7 000	Rp. 336.000
3	Penambahan	Penambahan Stiki note	Memenuhi kebutuhan RM	Pengajuan Order logistik di simrs	Unit RM	1th	Tersedia dan tercukupi stiki note	60	Pcs	Rp. 7 000	Rp. 420.000
4	Penambahan	Penambahan Remover	Memenuhi kebutuhan RM	Pengajuan Order logistik di simrs	Unit RM	1th	Tersedia dan tercukupi remover	12	Pcs	Rp. 5000	Rp. 60.000
5	Penambahan	Penambahan Steples	Memenuhi kebutuhan RM	Pengajuan Order logistik di simrs	Unit RM	1th	Tersedia dan tercukupi steples	12	Pcs	Rp. 10.000	Rp. 120.000
6	Penambahan	Penambahan Isi staples	Memenuhi kebutuhan RM	Pengajuan Order logistik di simrs	Unit RM	1th	Tersedia dan tercukupi isi staples	12	Pcs	Rp. 70.000	Rp. 840.000



7	Penambahan	Penambahan Tinta printer	Memenuhi kebutuhan RM	Pengajuan Order logistik di simrs	Unit RM	1th	Tersedia dan tercukupi tinta printer	24	Botol	Rp. 80.000	Rp. 1.920.000
8	Penambahan	Penambahan Tinta spidol	Memenuhi kebutuhan RM	Pengajuan Order logistik di simrs	Unit RM	1th	Tersedia dan tercukupi tinta spidol	12	Botol	Rp. 25.000	Rp. 300.000
9	Penambahan	Penambahan Stabilo	Memenuhi kebutuhan RM	Pengajuan Order logistik di simrs	Unit RM	1th	Tersedia dan tercukupi stabilo	12	Pcs	Rp. 10.000	Rp. 120.000
10	Penambahan	Penambahan Perforator	Memenuhi kebutuhan RM	Pengajuan Order logistik di simrs	Unit RM	1th	Tersedia dan tercukupi perforator	4	Pcs	Rp. 50.000	Rp. 200.000
11	Penambahan	Penambahan Solasi	Memenuhi kebutuhan RM	Pengajuan Order logistik di simrs	Unit RM	1th	Tersedia dan tercukupi solusi	12	Pcs	Rp. 3000	Rp. 36.000
12	<i>Inhouse training</i> wajib di Rumah Sakit (BHD, PPI Dasar, PMKP, Komunikasi Efektif)	Pelatihan bhd ppi dan pmkp serta komunikasi efektif	Update ilmu tentang inhouse training untuk tercapainya mutu rumah sakit	Usulan melalui SDM	Seluruh Unit RM	1 Th	Paham dan mengerti serta dapat diaplikasikan setiap hari dengan baik dan benar	1 (22 orang yang mengikuti)	SDM	Rp.500.000	Rp.500.000
12	<i>Pelatihan Coding</i>	Pelatihan Coding ICD-10	Meningkatkan kemampuan coding ICD-10 agar akurat	Usulan melalui SDM	Seluruh unit RM	1 Th	Mampu melakukan coding ICD-10 dengan benar dan akurat	1	SDM	Rp. 500.000	Rp. 500.000



13	Pelatihan Rekam Medis Elektronik	Pelatihan Rekam Medis Elektronik	Meningkatkan mutu pelayanan di RS	Usulan manajemen	RS	1 th	Terlaksananya proses keberhasilan penginputan data pasien ke simrs RM-e	1	SDM	Rp. 400.000	Rp. 400.000
14	Pelatihan Etika dan Kerahasiaan Data Pasien	Pelatihan Etika dan Kerahasiaan Data Pasien	Menjaga etika profesi & keamanan data	Usulan melalui SDM	Staff RM	1 th	Memahami dan menerapkan kerahasiaan data	1	SDM	Rp. 300.000	Rp. 300.000
15	Pelatihan Penggunaan SIMRS (Electronic Rekam Medis)	Pelatihan Penggunaan SIMRS (Electronic Rekam Medis)	Standardisasi penggunaan SIMRS	Usulan ke IT/SDM	Staff RM dan pendaftaran	1 th	Penginputan data akurat dan sesuai SOP	1	SDM	Rp. 500.000	Rp. 500.000
16	Pelatihan Audit Internal Rekam Medis dan Evaluasi Data Pasien	Pelatihan Audit Internal Rekam Medis dan Evaluasi Data Pasien	Meningkatkan kemampuan audit & evaluasi	Usulan ke mutu/SDM	Staff RM	1 th	Mampu audit DRM & hasil dilaporkan	1	SDM	Rp. 350.000	Rp. 350.000
17	Komunikasi efektif KIE pasien	Komunikasi efektif KIE pasien	Meningkatkan skill komunikasi pelayanan	Usulan melalui SDM	Seluruh staff Pendaftaran	1 th	Pelayanan komunikatif & akurat	1	SDM	Rp. 250.000	Rp. 250.000
18	Pelatihan etika dan pelayanan prima	Pelatihan etika dan pelayanan prima	Meningkatkan budaya pelayanan berorientasi pasien	Usulan melalui SDM	Seluruh staff Pendaftaran	1 th	Sikap pelayanan sesuai standar RS	1	SDM	Rp. 450.000	Rp. 450.000
19	Komputer set	Penambahan alat komputer	Memenuhi kebutuhan alat di RM	Pengadaan logistik simrs	RS	1 th	Alat di rekam medis terpenuhi	2	Fasilitas	Rp. 5.000.000	Rp. 10.000.000



20	Scanner	Penambahan alat scanner	Memenuhi kebutuhan alat di RM	Pengadaan logistik simrs	RS	1 th	Alat di rekam medis terpenuhi	1	Fasilitas	Rp. 10.000.000	Rp. 10.000.000
21	TAB	Penambahan alat Tab	Memenuhi kebutuhan alat di pendaftaran	Pengadaan logistik simrs	RS	1 th	Alat di pdf terpenuhi	1	Fasilitas	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000
TOTAL KEBUTUHAN ANGGARAN UNTUK PROGRAM INSTALASI REKAM MEDIS SEBESAR										Rp. 33.322.000	

Mengetahui
PLT Direktur RS Prima Husada



(dr. Resti Lestantini, M. Kes)

Diverifikasi oleh
Kepala Bidang Penunjang Medis

(Dwi Novianti, A.Md.AK,S.Kes)

Pelaksana Program
Kepala Instalasi Rekam Medis

(Annisa Aulia Savira,A.Md.Kes)

